

Fecha Última Actualización: 14-11-2022 13:43:45

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Junny Angélica Cifuentes Huenchumán **Rut** : 9.124.511-6 **N° Archivo** : A554974
Edad : 61a 6m 24d **Fecha Nacto**: 21/04/1961 **Sexo** : Femenino
Dirección : Los Maitenes 168 **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 955392217

N° Epicrisis
329503

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 27/10/2022 08:06 **Días Estadía**: 18
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad **Fecha Egreso** : 14/11/2022 13:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

DHC por NASH

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes Médicos: DHC obs NASH, DM2 IR, HTA, COVID 19 (Mayo a Junio de 2021), hipotiroidismo
Quirúrgicos: CCA, reciente operada del síndrome del túnel carpiano (derecho) y dedo en gatillo 3er dedo mano derecha
Fármacos: propranolol 10 mg cada 8 horas, lactulosa para deposiciones, furosemida 40 mg AM y a las 16 horas, espironolactona 150 mg vo/día. Magnatil 1 comp/día. Lactulosa 20 ml cada 8 horas. Aloelax 2 caps dos veces al día.). Insulina NPH 26-16 U. Sertralina 50 mg/día. Tramadol 50 mg/DIA sos.
Alergias: no conocidas
Hábitos: TBQ ocasional, OH (-) DROGAS (-)

Paciente con diagnóstico de DHC en 2021, de probable etiología NASH, en controles y seguimiento en policlinico de hepatología con Dra. Norero, ingresa desde su domicilio de forma electiva para someterse a cirugía de trasplante hepático. Ingresa en buenas condiciones generales, con HDN estable, ventilando espontáneamente, en GCS 15, sin signos de encefalopatía.

Se realiza día 27/10 trasplante ortotópico de hígado, piggyback, AHP sobre AHC, VP T-T, VB T-T tiempo quirúrgico 5 horas, TIF 3:20 hrs, TIC 30 min. Sale de pabellón sin requerimientos de DVA.

Es trasladada a UCI en post operatorio. Evoluciona de manera favorable, siendo extubada primer día del post operatorio. Sin requerimientos de DVA. Inicia inmunosupresión con metilprednisolona y recibe 2 dosis de Basiliximab. Perfil hepático evoluciona de manera esperada con disminución de transaminasas, bilirrubina y normalización del INR. Controles con ecodoppler muestran buen flujo al injerto, con estructuras vasculares permeables.

Dada buena evolución se decide traslado a intermedio quirúrgico.

En intermedio quirúrgico progresa en ingesta oral y movilidad. Inicia 02/11 inmunosupresión con tacrolimus. Sin mayores conflictos es trasladada a sala.

Evoluciona en buenas condiciones, afebril, con episodios intermitentes de dolor en HD, con buena tolerancia oral. En seguimiento por equipo de hepatología y control con exámenes. Control de pruebas hepáticas del 05/11 muestra elevación de transaminasas por lo que se decide ajustar Tacrolimus (4 mg).

Evoluciona clínicamente con ascitis. El 07/11 se realiza Ecografía abdominal que impresiona área del lecho con imagen mixta de 3.8 x 2.5 cm, presenta ascitis libre en todo el abdomen sin ecos densos en suspensión. El citoquímico del líquido ascítico muestra Prot totales 23, glucosa 137 y células 600 (MN 55% y PMN 45%), cultivos pendientes. Se ajusta tratamiento con furosemida.

Presenta síntomas urinarios, por lo que se toma orina completa y urocultivo, resultando con E. Coli Blee (+). Completa 13/11 5

Fecha Epicrisis : 14/11/2022 13:43

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 14-11-2022 13:43:45

Página 2 de 2

días de tratamiento con Meropenem.

Actualmente sin molestias urinarias, buena tolerancia oral, sin dolor, sin fiebre. Dada evolución favorable se decide alta.

Dada buena evolución clínica, se decide el alta hospitalaria de la paciente para continuar seguimiento de forma ambulatoria.

Diagnóstico de Egreso

TRANSPLANTE DE HÍGADO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente egresa en buenas condiciones generales, HDN estable, afebril, con PCR covid (). Actualmente con ascitis y tratamiento asociado.

Plan Post Alta

Régimen liviano - blando

Reposo relativo, levantar diariamente.

Aciclovir 400 mg, 1 comprimido cada 12 horas VO x 30 días.

Cotrimoxazol forte, 1 comprimido cada 24 horas VO, dar Lunes, miércoles y viernes x 30 días

Espironolactona 25 mg, 2 comprimidos cada 24 horas VO x 30 días

Furosemida 20 mg, 1/2 comprimido cada 12 horas VO x 30 días

Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 24 horas VO si presenta dolor.

Acido acetilsalicílico 100 mg, 1 comprimido cada 24 horas VO x 30 días.

Omeprazol 20 mg, 1 comprimido cada 24 horas VO x 30 días.

Prednisona 20 mg, 1 comprimido cada 24 horas VO x 30 días.

Pregabalina 75 mg, 1 comprimido cada 24 hrs VO x 30 días.

Tacrolimus 6mg C/12 hrs VO x 30 días.

Control de exámenes jueves 17/11 con Enfermera de transplante en CDT a las 08:50.

Control con Dr. Rebolledo jueves 17/11 a las 09:30 en CDT pasillo 11

Control con Dr. Martínez viernes 18/11 09:00 AM CDT pasillo 11.

Consultar al servicio de urgencias en caso de dolor intenso, fiebre, vómitos, sangrados o según usted estime conveniente.

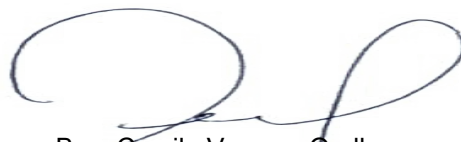
Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles



Bec. Camila Vergara Orellana

Becado/Residente

INTERNO

Médico Tratante (Staff)